



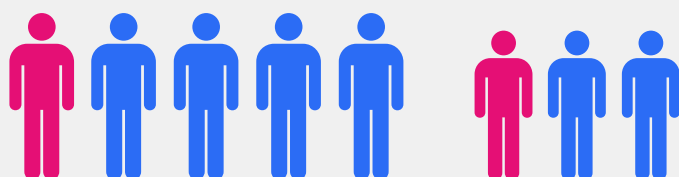
ZESPÓŁ BÓLU RZEPKOWO- UDOWEGO

Czym jest i wskazówki dotyczące leczenia

Czym jest zespół bólowy rzepkowo-udowy?

Zespół bólu rzepkowo-udowego (PFP) to nieprzyjemna dolegliwość, która dotyka wielu osób w każdym wieku i na każdym poziomie aktywności. Może objawiać się bólem z przodu kolana, wokół i/lub za rzepką/rzepkami, wywoływanym przez czynności wymagające zginania i prostowania kolana, takie jak bieganie, chodzenie, siadanie/wstawanie, a nawet wchodzenie/schodzenie po schodach.

Diagnozę PFP zazwyczaj przeprowadza się, wykluczając inne schorzenia jako przyczynę. Około 1 na 5 dorosłych i ponad 1 na 3 nastolatków doświadcza PFP rocznie (rys. 1). Jest to bardziej powszechne u osób bardzo aktywnych, takich jak sportowcy, ale nie jest też rzadkością u osób prowadzących siedzący tryb życia lub mniej aktywnych.



Rycina 1. Około 1/5 dorosłych i ponad 1/3 nastolatków będzie doświadczać PFP każdego roku

Dlaczego mam PFP?

Przyczyny PFP są wieloaspektowe i różnią się w zależności od osoby. Niektóre z czynników, które mogą przyczyniać się do rozwoju PFP to:

- Wysoki poziom aktywności fizycznej (przekraczający poziom tolerancji) i niewystarczający odpoczynek.
- Nagłe zmiany aktywności fizycznej, np. powszechne u początkujących biegaczy lub sportowców przechodzących z przerw sezonowych na treningi i zawody.
- Czynniki strukturalne związane z problemami ze śledzeniem stawu lub rzepki.
- Pewne wzorce ruchu, które mogą zwiększać obciążenie kolana, np. nadmierna pronacja stopy.
- Osłabienie mięśni bioder i/lub ud.
- Wcześniejsza niewydolność/niestabilność kolana

Zaleca się kontrolę i terapię u terapeuty metody P-Dtr w celu ustalenia przyczyny nadmiernego przeciążenia kolana

Co mogę zrobić, aby złagodzić moje objawy?

Twój fizjoterapeuta może udzielić Ci informacji i porad, ale Twoja własna aktywność i zaangażowanie są niezbędne do optymalnego powrotu do zdrowia. Ćwiczenia i zarządzanie obciążeniem są kluczowymi filarami obecnie zalecanego leczenia. Inne metody leczenia powinny działać jedynie jako dodatek do ćwiczeń i zarządzania obciążeniem.

1. P-Dtr i ćwiczenia

Terapia P-Dtr w celu usprawnienia mięśni i aparatu ruchu i dalsze ćwiczenia jest najważniejszym elementem zarządzania PFP. Celem jest zarządzanie i poprawa wszelkich możliwych deficytów w funkcjonowaniu mięśni, sile lub wzorcach ruchu oraz zwiększenie zdolności do radzenia sobie z obciążeniem.

Ćwiczenia często obejmują ćwiczenia wzmacniające mięśnie bioder, ud, stóp i brzucha, a także ćwiczenia rozciągające i poprawiające koordynację ruchową.

Zwykle możesz spodziewać się, że ćwiczenia i intensywność obciążenia kolana będą się zmieniać w miarę postępu objawów. Podczas końcowych etapów rehabilitacji ćwiczenia często naśladują ruchy i czynności, których potrzebujesz w codziennym życiu.

Celem jest, abyś nauczył się samodzielnie wykonywać plan ćwiczeń w miarę postępów rehabilitacji. Jeśli jednak czujesz, że potrzebujesz więcej porad i/lub wsparcia, lub że Twoja niepewność lub strach utrudniają Ci ukończenie zaplanowanych ćwiczeń i bycie aktywnym, poinformuj o tym swojego specjalistę.

Aby ćwiczenia były skuteczne, konieczne są regularne ćwiczenia oraz kontrola mięśni u fizjoterapeuty/lekarza

2. Modyfikacja aktywności i zarządzanie obciążeniem

Zarządzanie obciążeniem stawu rzepkowo-udowego jest drugim najważniejszym elementem zarządzania PFP. Zasadniczo wymaga dostosowania obciążenia, jakie nakładasz na kolano, poprzez zmianę i modyfikację rodzaju, intensywności i częstotliwości aktywności fizycznej, aby zrównoważyć stres i regenerację.



Rysunek 2. Pozioma linia strzałki = czas, pionowa linia strzałki = obciążenie

Zazwyczaj trzeba początkowo zmniejszyć obciążenie, a następnie stopniowo, krok po kroku...

krok po kroku zwiększaj go w miarę tolerancji (**rys. 2**). Może to oznaczać zmiany w częstotliwości wykonywania aktywności i intensywności, ale może to również obejmować zmiany w aktywnościach, w których bierzesz udział.

Na przykład, jeśli Twoje objawy są łatwo wywoływane przez sport lub inną aktywność, w której bierzesz udział, możesz musieć zrobić sobie przerwę na początku, aby zmniejszyć drażliwość objawów. Kroki, które będziesz musiał podjąć, zależą od Twojej indywidualnej sytuacji. Zobacz kilka przykładów, jak możesz rozważyć modyfikację swojej aktywności i/lub zarządzać obciążeniem w polu 1.

POLE 1: Modyfikacja obciążenia może obejmować zmianę:

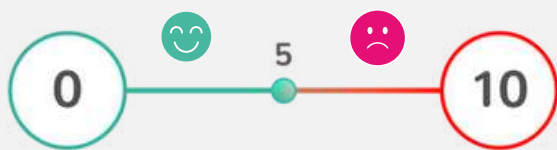
- Twoja aktywność na coś, co mniej obciąża Twoje kolano (np. bieganie na chodzenie)
- Częstotliwość wykonywania aktywności (np. 5 razy w tygodniu na 2)
- Długość okresów aktywności (np. 1 godzina na 30 minut lub 10 km na 5)
- Czas odpoczynku przed ponownym wykonaniem aktywności (np. brak dni odpoczynku na 2 dni odpoczynku)
- Miejsce wykonywania aktywności (np. na twardej lub miękkiej nawierzchni, na ścieżce z wieloma pagórkami lub na płaskiej ścieżce)
- Sposób wykonywania aktywności (np. kontynuowanie uczestnictwa w treningu, ale zmniejszenie intensywności lub zaprzestanie wykonywania ćwiczeń, które są najbardziej prowokujące, zmiana z biegania na bieganie i chodzenie)

Monitorowanie bólu jako część zarządzania obciążeniem

Ważne jest, aby zwracać uwagę na swoje objawy, ale nie niepokój się, jeśli odczuwasz ból podczas ćwiczeń. Nasilony ból nie zawsze oznacza, że doszło do większej szkody. Przeczytaj więcej o znaczeniu bólu w polu 2.

Nic nie stoi na przeszkodzie, aby odczuwać pewien dyskomfort podczas i po ćwiczeniach. Jednak jeśli ból stanie się zbyt intensywny, potraktuj to jako znak, że możesz się za bardzo starać, za wcześnie.

Częstą rekomendacją jest utrzymywanie poziomu bólu poniżej 5 w skali od 0 do 10. Może się to jednak różnić w zależności od osoby. Omów odpowiedni próg bólu ze swoim lekarzem, aby dostosować podejście do swoich potrzeb.



Rycina 3. W skali od 0 do 10 możesz starać się utrzymywać ból na poziomie 5 lub niższym podczas oraz bezpośrednio po ćwiczeniach i czynnościach obciążających kolano, chyba że ustalono inny zakres ze swoim specjalistą.

RAMKA 2: Ból

- Ból niekoniecznie oznacza krzywdę lub uraz. To subiektywne doświadczenie, unikalne dla każdej osoby. Ból działa jak system alarmowy, ostrzegając nas o potencjalnym zagrożeniu dla naszego ciała. Jednak jest on również pod wpływem naszych myśli, przeszłych doświadczeń, emocji i środowiska społecznego. Dlatego czynniki takie jak stres, lęk, zły nastrój i zmęczenie mogą nasilać odczuwanie bólu. Czasami ten system alarmowy może się mylić, szczególnie gdy ból utrzymuje się.

Zajęcie się wszelkimi negatywnymi emocjami, problemami ze snem i ogólną samoopieką jest kluczowe dla twojego powrotu do zdrowia, nie tylko skupianie się na problemach z kolanami. Holistyczne podejście do twojego dobrego samopoczucia usprawni proces twojego powrotu do zdrowia.

3. Taping rzepki

Owijanie rzepki może być pomocne w zmniejszeniu bólu kolana w krótkim okresie. Może to pomóc Ci pozostać aktywnym i wykonywać ćwiczenia. Twój lekarz może nauczyć Cię aplikacji taśmy rzepkowej, która najlepiej odpowiada Twoim potrzebom, abyś mógł ją ponownie nałożyć samodzielnie. Ortezy kolanowe lub rękawy są generalnie niezalecane.

4. Wkładki i obuwie

W niektórych przypadkach wkładki i/lub zmiana obuwia mogą być korzystne. Na przykład, jeśli jesteś biegaczem, możesz rozważyć wypróbowanie butów minimalistycznych, ponieważ mogą one zmniejszyć obciążenia kierowane na staw rzepkowo-udowy podczas biegania. Jednak zanim zainwestujesz w nowe buty, ważne jest, aby zauważyć, że nie wiemy jeszcze, jak korzystne są buty minimalistyczne pod względem leczenia bólu.

Osoby z nadmierną pronacją stopy mogą skorzystać z wkładek, które wspierają pozycję stopy. Twój lekarz może ocenić Twoją potrzebę wkładek i doradzić Ci, gdzie je zdobyć, jeśli zajdzie taka potrzeba. Jeśli wkładki są dla Ciebie zalecane, nie musisz inwestować w wkładki robione na zamówienie, ponieważ gotowe wkładki wydają się być równie skuteczne. Stosowanie wkładek jest również zalecane tylko w krótkim okresie (do 6 tygodni).

5. Terapia manualna i Metoda P-Dtr

Kluczowym etapem pracy jest odczulanie układu nerwowego za pomocą metody PDTR. Polega to na odnalezieniu obszarów przeciążeń lub dawnych urazów oraz „zresetowaniu” sygnałów receptorowych. Dzięki temu eliminujemy błędne odpowiedzi układu nerwowego, które powodują ból, ograniczenia ruchu i nadmierną ochronę mięśni i stawów.

Powinno to być wykonane PRZED ćwiczeniami i aktywnością fizyczną



Czego się spodziewać?

Udział w programie rehabilitacyjnym opracowanym z fizjoterapeutą może pomóc Ci zmniejszyć objawy i funkcjonowanie. Istnieje jednak 50% szans, że możesz odczuwać pewne objawy nawet po latach. Możesz pozytywnie wpłynąć na swoje rokowanie poprzez:

- rozpoczęcie rehabilitacji tak wcześnie, jak to możliwe.
- zaangażowanie w terapię ruchową
 - osoby, które nie stosują się do programu rehabilitacji, są czterokrotnie bardziej narażone na długotrwałe bóle.
- zobowiązanie do zarządzania obciążeniem
 - uznając, że jeśli Twój lekarz zaleci Ci przerwę w uprawianiu sportu, jest to ważne dla Twojego zdrowia w dłuższej perspektywie, nawet jeśli może się to wydawać trudne.
- dbanie o swoje ogólne zdrowie
 - dąż do utrzymania zdrowej wagi i skup się na swoim zdrowiu psychicznym

Zeskanuj kod QR, aby uzyskać dostęp do
odniesień do artykułów

